

Sclérodémie systémique

I. Introduction – Définition :

- Sclérodémies : affections ayant en commun une sclérose cutanée.
- Sclérodémie systémique : s'accompagne souvent de manifestations viscérales pouvant mettre en jeu le pronostic vital
- Il s'agit d'une connectivite rare
- Plus fréquente chez la femme (3 femmes pour 1 homme)
- Age de début : 40 à 50 ans le plus souvent

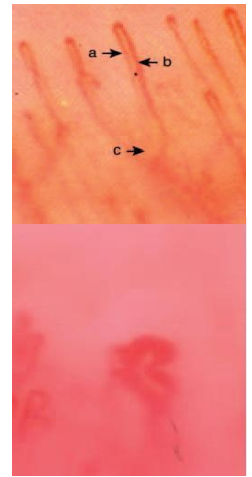
II. Physiopathologie :

- Anomalies du tissu conjonctif : accumulation de la matrice extracellulaire avec excès de fibres collagènes (fibrose tissulaire et vasculaire)
- Atteinte micro vasculaire oblitérante
- Désordres immunologiques
- Facteurs de risques parfois retrouvés : silice, solvants

III. Clinique – Paraclinique :

1. Phénomène de Raynaud :

- 90 à 95 % des cas : Souvent inaugure la maladie ++++
- Sévère ++++ avec des complications à type d'ischémie et d'ulcérations +/- surinfection
- Peut toucher toutes les extrémités (mains, pieds, lèvres, nez, oreilles)



- Capillaroscopie : Présence de méga-capillaires, raréfaction des capillaires, hémorragies sous unguéales

2. Manifestations cutanées :

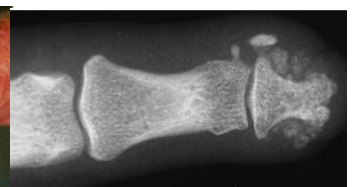
• Fibrose et épaissement cutané :

- Extrémités +++, bilatérale et symétrique.
- Puis tend à s'étendre vers les zones proximales en fonction de la forme clinique.
- Impossibilité de la pincer entre le pouce et l'index
- Rétraction des doigts en flexion
- Limitation de l'extension des coudes
- Appréciée par le score de **Rodnan** : (utile pour le suivi)
- Limitation d'ouverture de la bouche (distance inter incisives)
- Amincissement des lèvres
- Nez effilé
- Plis radiés en péri-buccaux



• Télangiectasies : visage, décolleté et mains.

• Calcinose sous cutanée : zones de traumatisme, face d'extension des articulations



3. Manifestations ostéo-articulaires :

- Arthralgies, raideur, rarement arthrites, les déformations des mains sont en rapport avec la rétraction des doigts liée à la sclérose cutanée.

4. Manifestations musculaires :

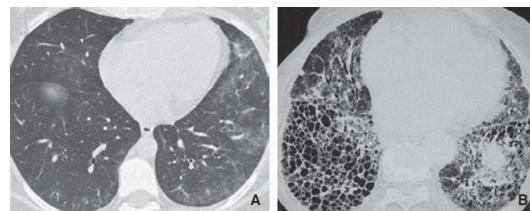
- Myalgie, ou véritable myosite, plus souvent dans les formes diffuses.

5. Manifestations digestives : +++++ (75 – 90 %)

- **Œsophage** : hypomotilité et hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage (manométrie œsophagienne) responsable d'un reflux gastro-œsophagien, pyrosis +/- dysphagie.
Complications : œsophagite peptique, endobrachy-œsophage voire adénocarcinome (FOGD)
- **Estomac** : gastroparésie, dyspepsie, nausées, vomissements
- **Intestin grêle** : Sd. pseudo-occlusif, diarrhée, malabsorption ; (dénutrition et cachexie)
- **Colon** : Sd. pseudo-occlusif, ballonnement, constipation, douleurs abdominales.
- **Anus et rectum** : incontinence anale, prolapsus rectal

6. Pneumopathie interstitielle diffuse : MAUVAIS PRONOSTIC

- Clinique : dyspnée d'effort d'aggravation progressive, crépitant aux bases, toux sèche.
Rx poumon : normale ou opacités réticulaires
TDM thoracique HR++ : opacités en verre dépoli ou en rayon de miel.
EFR : Sd. restrictif



7. Hypertension artérielle pulmonaire : MAUVAIS PRONOSTIC, CAUSE DE DÉCÈS

- Clinique : asymptomatique ou dyspnée d'effort d'aggravation progressive inexpliquée par une atteinte cardiaque ou parenchymateuse / Signes d'insuffisance cardiaque droite / Syncope ; hémoptysie
Échodoppler cardiaque +++ : dépistage annuel et en cas de dyspnée

8. Manifestations cardiaques :

- Fréquentes mais souvent asymptomatique.
- Atteinte de la microcirculation coronarienne
- Dysfonction du VG +/- dysfonction du VD
- Péricardite de petite abondance, rarement tamponnade
- Troubles du rythme et troubles de la conduction avec possibilité de mort subite
- ECG, échodoppler, IRM cardiaque

9. Crise rénale sclérodermique :

- 4% des cas
- Pourrait être favorisée par une corticothérapie, elle est liée à l'atteinte des artérioles rénales
- **HTA sévère et/ou insuffisance rénale rapidement progressive oligo-anurique avec schizocytes** au frottis sanguin (hémolyse)
- Mortalité élevée : jusqu'à 50% à 5 ans
- Intérêt de la surveillance régulière de la TA et de la créatininémie

IV. Formes cliniques :

- CREST syndrome : calcinose - Raynaud - atteinte œsophagienne - sclérodactylie - télangiectasies (meilleur pronostic)
- Forme diffuse : sclérose proximale, avec atteintes viscérales (mauvais pronostic)
- Forme limitée : la sclérose cutanée est distale ne dépassant pas les coudes, ni les genoux.
Les manifestations viscérales sont rares.
HTAP possible au cours de l'évolution.
- Formes associées :
Cirrhose biliaire primitive (Sd. de Reynolds)
Le Sd. de Gougerot-Sjögren
Les autres connectivites : Silicose (Sd. d'Erasmus)

V. Auto-anticorps :

- Anticorps antinucléaires : 90%
- Anticorps anti-centromères dans les formes limitées
- Anticorps anti-topo-isomérase I ou anti-scl70 (Formes diffuses)
- Anticorps anti-polymérase III dans les formes avec atteinte rénale

Item	Sous-Item	Score
Sclérose cutanée des doigts s'étendant au-delà des articulations métacarpophalangiennes (critère suffisant)		9
Épaississement des doigts (seul compte le score le plus élevé)	Doigts boudinés	2
	Sclérodactylie	4
Lésions digitales distales (seul compte le score le plus élevé)	Ulcération digitale	2
	Cicatrices pulpaire	2
Télangiectasies		2
Anomalies à la capillaroscopie		2
Atteinte interstitielle pulmonaire ou hypertension artérielle pulmonaire (score maximal = 2)	Atteinte interstitielle pulmonaire	2
	Hypertension artérielle pulmonaire	2
Phénomène de Raynaud		3
Autoanticorps en rapport avec la ScS (score maximal = 3)	Anticentromère	3
	Anti-topo-isomérase I	
	Anti-ARN polymérase III	

ScS : sclérodermie systémique; ARN : acide ribonucléique.

^a Ces critères sont applicables à tout patient pouvant être inclus dans une étude sur la ScS. Ils ne sont pas applicables à des patients qui ont des épaississements cutanés épargnant les doigts ou à des patients ayant une pseudosclérodermie pouvant mieux expliquer leurs manifestations (par exemple fibrose néphrogénique, morphee généralisée, fasciite à éosinophiles, sclérose diabétique, scléromyxœdème, érythromyalgie, porphyrie, lichen scléreux, réaction du greffon contre l'hôte, chéiroarthropathie diabétique). Le score total est déterminé par l'addition des scores maximaux dans chaque catégorie. Les patients totalisant un score supérieur à 9 sont classés comme ayant une ScS.

VI. Diagnostic différentiel :

- **Syndromes sclérodémiformes :**
 - Réaction du greffon contre l'hôte
 - Fasciite à éosinophiles (Shulman)
 - Chéiroarthropathie diabétique : (sclérodactylie piégeante)
 - Sd. de Werner : vieillissement précoce Sd sclérodémiforme paranéoplasique
- **Sclérodermie localisée :** les Morphées

VII. Prise en charge :

- Traitements symptomatiques +++
- Traitement immunosuppresseur en cas de sclérodermie diffuse de diagnostic récent (3 à 5 ans) et/ou PID évolutive
- Le but est de soulager, d'améliorer la qualité de vie et d'éviter au maximum les complications.
- **Phénomène de Raynaud :**
 - Protection contre le froid, éviction des produits corrosifs, éviter les B bloquants, et les vasoconstricteurs, éviter le tabac
 - Inhibiteurs calciques
 - Antagonistes des récepteurs de l'endothéline
- **Sclérose cutanée :**
 - Kinésithérapie +++
 - Immunosuppresseurs dans les formes aiguës rapidement progressives
- **HTAP :** antagoniste des récepteurs de l'endothéline
- **Pneumopathie interstitielle évolutive :** immunosuppresseurs
- **RGO :** règles hygiéno-diététiques / inhibiteurs de la pompe à proton, prokinétiques
- **Crise rénale :** IEC, voir hémodialyse